

17 - 03- LES PERICARDITES CHRONIQUES - Pr. Benzeroual

Nous arrivons à présent au troisième volet des pathologies du péricarde, c'est la péricardite chronique constrictive. Il y a une maladie inflammatoire chronique du péricarde. Elle est caractérisée par la transformation du péricarde en coque fibreuse, plus ou moins épaisse, parfois calcifiée, constituant une gaine qui gêne le remplissage des ventricules.

Une fois le péricarde transformé, il va constituer une coque fibreuse en gainant le cœur et touchant les deux ventricules. Ceci va gêner le remplissage des ventricules. En protodiastole, la phase où le ventricule se distend et se remplit, la paroi ventriculaire se distend à l'origine d'une dépression.

C'est-à-dire qu'on aura une baisse de la pression dans les ventricules pour préparer le remplissage. Lors de cette protodiastole, on va enregistrer un dip, c'est-à-dire une baisse de la pression du ventricule. Mais cette baisse de la pression va être rapidement freinée par cette coque fibreuse, calcifiée parfois du péricarde, en meso- et télédiastole.

Donc la distension ventriculaire va être freinée et arrêtée et on aura un mouvement de plateau. Regardez ici sur cette courbe de pression ventriculaire des deux ventricules, le VG et le VD. On est en phase de la diastole.

Dans la diastole, la pression au sein des deux ventricules va diminuer. C'est l'aspect en dip. Cette pression en situation normale va continuer à baisser pour préparer le remplissage.

Cependant, on a dit que la pression va diminuer en protodiastole, c'est-à-dire en début de la diastole. Puis du fait de la présence de cette coque fibreuse, parfois calcifiée, ce mouvement de distension est limité. Et après, on aura cet aspect de plateau.

Cet aspect est caractéristique dans les courbes de pression ventriculaire. C'est ce qu'on appelle le dip plateau, un dip où l'aspect en racine carrée baisse de la pression, puis un aspect en plateau. Le diagnostic positif, on va avoir comme signe fonctionnel, une dyspnée d'effort ou de repos modéré, parfois des hépatalgies d'effort, une asthémie généralisée.

On peut avoir comme signe physique des signes périphériques, une turgescence des veines jugulaires, une pression veineuse centrale élevée, une hépatomégalie, des œdèmes des membres inférieurs, une ascite. C'est-à-dire tous les signes d'insuffisance cardiaque droite. L'examen cardiovasculaire, on va avoir une pression artérielle qui est pincée, c'est-à-dire la différence entre la PAS et la PAD est pincée.

Un pont paradoxal, et vous savez ce que c'est, une tachycardie, une arythmie. Parfois, on a le signe de la vibration péricardique. C'est un bruit protodiastolique, bref et claqué.

Mais sincèrement, c'est un bruit qui est entendu exceptionnellement. Sur le plan

électrocardiographique, on a une hypertrophie auriculaire gauche, une hypertrophie. On peut avoir une hypertrophie auriculaire droite, un microvoltage, une fibrillation atriale.

Des anomalies de lenté sont quasi constantes. La radiographie du thorax, elle permet de voir que le volume cardiaque est normal, pas de cardiomégalie. Elle permet aussi de rechercher des calcifications précordiales évocatrices d'une péricardite tuberculeuse, mais pouvant se rencontrer aussi dans d'autres pathologies.

Voici une radiographie du thorax. C'est une vue radiographique du thorax de profil. C'est au profil que l'on voit l'aspect calcifié du feuillet péricardique que, normalement, on ne voit pas.

L'échocardiogramme montre un péricarde épaissi, calcifié, avec dilatation du massif atrial. Les ventricules sont de taille normale et on a des variations respiratoires du flux transvalvulaire. Quand on prend les vitesses des flux à travers les valves, soit la valve mitrale, aortique, tricuspideenne, on a des variations de ces vitesses selon le cycle respiratoire.

Entre l'inspiration et l'expiration, on a des variations qui dépassent les 20% entre les deux cycles. La veine cave inférieure étant dilatée aussi. Le cathétérisme cardiaque, c'est là où on va étudier la pression dans les ventricules.

Il montre l'aspect caractéristique de deep plateau ou l'aspect en racines carrées expliquée en physiopathologie. Les étiologies, la principale étiologie étant la tuberculose. Nous sommes un pays d'endémies, évolution lente et insidieuse.

Parfois, c'est le post-opératoire après une chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Post-radique, après 5 à 10 séances de radiothérapie, mais de moins en moins puisque la radiothérapie est plutôt ciblée. D'origine néoplasique, parfois d'origine purulente et encore plus rarement, l'évolution vers la chronicité quand il s'agit d'épanchement dans le cadre de maladies du système.

Le traitement, un seul traitement curatif, c'est la décortique à sang. C'est enlever, décortiquer ce péricarde qui est devenu calcifié. On peut donner un traitement symptomatique, le repos, le régime des sondés, les diurétiques, la ponction d'acide.

Si il y en a la ponction d'une pleurésie, donc en fonction, si on a une fibrillation atria, il faudra anticoaguler. Si on a une péricardite tuberculeuse, il faudra donner les antibacilles.